

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

CONCURSO-OPOSICIÓN 2023 PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE:
MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA

ADVERTENCIAS:

- ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con TELEFONO MÓVIL (o dispositivo electrónico conectado a datos, en general).
- EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL TELEFONO MÓVIL ANTES DE ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.
- ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.
- NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.

- Compruebe que en su «**Hoja de Respuestas**» están sus datos personales, que son correctos, y **no olvide firmarla**.
- **El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.**
- **Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto cuando se indique.**
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. PARA ELLO LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «**1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO**» y «**2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO**».

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba teórica deben ser contestadas en la «**Hoja de Respuestas**», numeradas de la 1 a la 100.
 - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a «**Reserva**» de la «**Hoja de Respuestas**», numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor y sumarían un máximo de 50 puntos.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
 - Las preguntas de esta prueba práctica deben ser contestadas en la «**Hoja de Respuestas**», numerada de la 101 a la 150.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor y sumarían un máximo de 50 puntos.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
- Solo se calificarán las respuestas marcadas en su «**Hoja de Respuestas**».
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su «**Hoja de Respuestas**» es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
- Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU «HOJA DE RESPUESTAS», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUADERNILLO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO. Si desea un ejemplar puede obtenerlo en la página web del Organismo.

**CONTINÚA EN LA
CONTRAPORTADA**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

APES_MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA 2023 / TURNO LIBRE

CUESTIONARIO TEÓRICO

-
- 1 En el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Andalucía se reconoce la Salud como un derecho, haciéndose eco el legislador del mandato de la Constitución que garantiza la protección de la salud como derecho constitucional. Señale a través de qué instrumento o medio se garantizará este derecho, según se dicta en este mismo artículo del Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo):**

 - A) Mediante un sistema sanitario público de carácter universal.
 - B) A través de Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
 - C) Mediante convenios y conciertos entre el proveedor público de servicios sanitarios y las entidades privadas del sector sanitario.
 - D) A través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
 - 2 La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) tiene como objetivo el desarrollo y gestión de recursos de apoyo social para personas con dependencia y discapacidad derivada de padecer trastornos mentales graves. Señale a qué órgano directivo de la actual Consejería de Salud y Consumo está adscrita esta entidad instrumental, y tiene asignados la orientación, tutela y gestión técnica de FAISEM:**

 - A) Viceconsejería.
 - B) Secretaría General Técnica.
 - C) Secretaría General de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria y Consumo.
 - D) Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones.
 - 3 El vigente RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos) establece unos principios generales relativos al tratamiento de los datos personales, entre los que se encuentran los siguientes, EXCEPTO:**

 - A) Principios de licitud, lealtad y transparencia.
 - B) Principio de limitación del plazo de conservación.
 - C) Principio de seguridad digital.
 - D) Principio de minimización de datos.

- 4 **Según el artículo 11 de la Ley 55/2003 (del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud), el Foro Marco para el Diálogo Social depende de:**
- A) La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
 - B) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
 - C) El Ministerio de Sanidad.
 - D) La Mesa Sectorial de Sanidad.
- 5 **Según la Ley 41/2002 (básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica), los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo:**
- A) 4 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
 - B) 5 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
 - C) 10 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
 - D) 15 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
- 6 **Referido al "Modelo de Acreditación de Competencias Profesionales" en el ámbito del SSPA, son correctas todas las respuestas que siguen, EXCEPTO:**
- A) La acreditación consiste en el reconocimiento expreso por parte de la Administración Sanitaria del desarrollo alcanzado por un profesional que se ha sometido a un proceso voluntario de evaluación para la mejora continua de sus labores asistenciales, docentes y de investigación.
 - B) La certificación se realiza verificando la presencia de competencias clave en la práctica real, de acuerdo a estándares determinados por la evidencia científica y el consenso de expertos.
 - C) El sistema de acreditación del nivel de la competencia profesional de los profesionales sanitarios del SSPA está regulado por el Decreto 18/2007, de 23 de enero.
 - D) La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), actualmente adscrita a la Consejería de Salud e integrada en la Fundación Progreso y Salud, es el órgano competente para la acreditación de la competencia profesional.
- 7 **El instrumento de que se dota la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud para establecer las actividades a realizar por sus centros y los recursos de que éstos dispondrán a lo largo de un año, enmarcados en el planteamiento de una sanidad pública gestionada con los profesionales, basada en los resultados en salud y orientada a prestar la mejor asistencia posible a los pacientes, se conoce por:**
- A) Plan Estratégico Anual.
 - B) Programa de Racionalización Operativa Anual (PROA).
 - C) Acuerdo de Gestión Clínica.
 - D) Contrato Programa.

8 La segunda opinión médica (SOM) es un derecho de las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud cuando estas padecen una enfermedad diagnosticada como de pronóstico fatal, incurable o que compromete gravemente su calidad de vida, o bien cuando el tratamiento propuesto conlleva un elevado riesgo vital. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre este derecho de segunda opinión médica y su regulación y acceso a la prestación del mismo en el ámbito del SAS es INCORRECTA?

A) Cuando una persona solicita una SOM, y esta resulta estimatoria según lo establecido en la normativa, un facultativo experto estudia la información procedente de su historia clínica y emite un informe que se envía directamente a la persona solicitante, o a quien esta haya autorizado para actuar en su nombre.

B) Para solicitar una SOM la persona solicitante debe haber sido diagnosticada previamente y no requerir tratamiento urgente o inmediato.

C) El ejercicio del derecho a la SOM, en los casos previstos en la normativa regulatoria, conlleva la libre elección de especialista y centro hospitalario por parte de la persona solicitante.

D) Es un requisito que el diagnóstico de la enfermedad o el tratamiento propuesto para la persona solicitante lo haya sido en cualquier centro dependiente del Servicio Andaluz de Salud.

9 Referido a la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) y su valoración, es cierto que:

A) La valoración de la CVRS se centra en una evaluación objetiva de las tres dimensiones fundamentales de funcionamiento de la persona: física, psicológica-cognoscitiva y social.

B) La valoración de la CVRS tiene interés sólo en estudios de investigación (como medición de resultados percibidos por el paciente), no siendo aplicable en la práctica clínica por su complejidad y variabilidad.

C) La mayoría de los instrumentos de evaluación de la CVRS son cuestionarios, que deben poseer cualidades psicométricas como validez, fiabilidad y sensibilidad a los cambios.

D) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

10 Referido a las pruebas paramétricas en Estadística Inferencial, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Cuantifican la asociación o independencia entre una variable cuantitativa y una categórica.

B) Exigen ciertos requisitos previos para su aplicación: distribución Normal de la variable cuantitativa en los grupos que se comparan, homocedasticidad de varianzas en las poblaciones de las que proceden los grupos y un tamaño muestral n no inferior a 30.

C) T de Student y ANOVA son las pruebas paramétricas más habituales.

D) Todas son correctas.

- 11 Usted está leyendo un artículo que publica los resultados de un gran ensayo clínico aleatorizado y doble ciego, de gran interés en su ámbito profesional. En concreto le llama la atención el resultado que muestra este estudio sobre la mortalidad global al comparar un nuevo tratamiento experimental con la terapia estándar hasta este momento, en una población de pacientes que tienen un perfil muy similar a los que se tratan en su Unidad. Este resultado publicado es: $RR = 0.71$ (IC95% 0.98-0.59, $p=0.046$). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**
- A) El valor p asociado al contraste no es significativo estadísticamente.
 - B) La reducción relativa del riesgo (RRR) para la variable "mortalidad global" es aproximadamente del 29%.
 - C) El NNT (número de pacientes que necesitaría tratarse con el nuevo tratamiento en vez del estándar para reducir un resultado de muerte por cualquier causa) sería 71.
 - D) La probabilidad de que estos resultados se deban al error del muestreo es del 95%.
- 12 Según la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica, ¿cuál de los siguientes estudios NO requerirá de la preceptiva evaluación y aprobación por un Comité de Ética de la Investigación (CEI)?**
- A) Un estudio descriptivo de las características clínicas, inmunológicas, genéticas y demográficas de una serie multicéntrica de pacientes diagnosticados de esclerosis sistémica.
 - B) Una tesis doctoral que evalúa la correlación entre varios tipos de analgesia local y el control del dolor secundario a extracción dental, que se va a llevar a cabo con pacientes atendidos en un gabinete odontológico conveniado con la universidad.
 - C) Un estudio experimental en conejos para evaluar una nueva molécula de posible efecto antiangiogénico, aplicándola intraocularmente.
 - D) Un estudio de tipo cualitativo con diseño de investigación-acción participativa que evalúa un programa de atención paliativa en domicilio involucrando a profesionales, pacientes y familiares.
- 13 Un estudio de investigación analiza la posible relación entre el consumo de carnes rojas y el desarrollo de determinadas neoplasias digestivas, en concreto cáncer colorrectal (CCR), bajo un diseño epidemiológico de "casos y controles". Está claro que la población de la que se obtendrían los "casos" serían pacientes diagnosticados de CCR, pero ¿cuál sería la población de la que se obtendrían los "controles" para llevar a cabo este estudio y obtener una estimación no sesgada del riesgo de CCR asociado a la ingesta de carnes rojas?**
- A) Pacientes diagnosticados de otras neoplasias digestivas y que reconozcan no ser vegetarianos.
 - B) Pacientes sin CCR que sean vegetarianos.
 - C) Pacientes sin CCR que provengan de la misma población de la que la provienen los casos.
 - D) Pacientes con CCR que reconozcan no comer carnes rojas.

- 14 Referida a las técnicas de muestreo en estudios de investigación, solo una de las siguientes es de tipo aleatorio o probabilístico:**
- A) Muestreo "bola de nieve".
 - B) Muestreo por cuotas.
 - C) Muestreo por conveniencia.
 - D) Muestreo estratificado.
- 15 El sistema de información sanitaria que recoge datos clínicos y del uso de recursos sanitarios de cada una de las personas que reciben asistencia sanitaria en el Servicio Andaluz de Salud, se conoce por:**
- A) BPS (Base Poblacional de Salud).
 - B) BDU (Base de Datos de Usuarios).
 - C) Historia Clínica Digital DIRAYA.
 - D) COANhYd.
- 16 Señale la respuesta verdadera en relación con las taquiarritmias supraventriculares:**
- A) El flúter auricular es una arritmia producida por la existencia de una vía accesorio oculta entre aurículas y ventrículos que recircula los impulsos.
 - B) El bloqueo del nodo AV con adenosina revierte a ritmo sinusal el flúter auricular.
 - C) La técnica de elección para la reversión al ritmo sinusal del flúter común o tipo I es la cardioversión eléctrica.
 - D) La maniobra de Valsalva postural o invertida se ha mostrado menos efectiva que la clásica para la reversión a ritmo sinusal de las taquiarritmias supraventriculares.
- 17 En el tratamiento del paciente con hemorragia gastrointestinal, ¿cuál de las siguientes respuestas es FALSA?**
- A) Los inhibidores de la bomba de protones (p. ej., Pantoprazol, bolo de 80 mg seguido de una infusión de 8 mg/h) se recomiendan para pacientes con sospecha de hemorragia gastrointestinal no varicosa.
 - B) El umbral para la transfusión de sangre debe ser menor en los ancianos.
 - C) Un aspirado por sonda nasogástrica negativo excluye de manera concluyente una hemorragia gastrointestinal alta.
 - D) Se estima que 80% de las hemorragias gastrointestinales inferiores se resuelven espontáneamente.
- 18 En relación con la tormenta eléctrica en pacientes portadores de un desfibrilador automático implantable, señale la verdadera:**
- A) Se trata de una disfunción del dispositivo.
 - B) En el tratamiento debe evitarse la sedación.
 - C) Consiste en la aparición de dos o más episodios separados de arritmias ventriculares que requieren choque eléctrico para su terminación en un periodo de 24 horas.
 - D) Está causada por la ausencia de intervención en taquicardias ventriculares.

- 19 Con respecto a la capnografía de onda para la medición del CO₂ espirado, señale la respuesta FALSA:**
- A) Es el método recomendado para verificar la colocación del tubo endotraqueal en la vía aérea.
 - B) Las cifras de CO₂ espirado pueden guiar acerca de la efectividad de la RCP.
 - C) Si no se alcanzan cifras superiores a 10 mmHg es improbable que la RCP tenga éxito.
 - D) Nos indica que el tubo endotraqueal está correctamente alojado en la tráquea.
- 20 En relación al paciente con shock, señale la verdadera:**
- A) Una presión arterial normal, descarta la situación de shock.
 - B) En un mismo paciente, no pueden coexistir distintos tipos de shock.
 - C) El índice de shock (cociente entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica) mayor de 0,8 indica un fracaso de la función del ventrículo izquierdo, y es el mejor indicador de severidad del shock.
 - D) La dopamina constituye la segunda droga de elección en el shock séptico, tras la noradrenalina.
- 21 En relación con las arritmias peri-parada y su tratamiento, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?:**
- A) En las taquiarritmias ventriculares con pulso, no es necesario sincronizar la descarga con la onda R del electrocardiograma (ECG).
 - B) En la fibrilación auricular, basándonos en los datos actuales, una estrategia razonable sería administrar una descarga sincronizada a la máxima energía del desfibrilador.
 - C) La desfibrilación es el tratamiento de elección para las taquiarritmias con pulso en el paciente inestable que presenta signos adversos potencialmente mortales.
 - D) En los pacientes conscientes en situación de inestabilidad no es necesaria la anestesia o sedación antes de intentar una cardioversión sincronizada.
- 22 En el caso de una bradicardia acompañada de signos adversos, ¿cuál de las siguientes opciones terapéuticas NO es correcta?**
- A) Si el tratamiento con atropina es ineficaz, considere los fármacos de segunda línea, como Isoprenalina y Adrenalina.
 - B) Considerar administrar Glucagón si la causa potencial de la bradicardia son los betabloqueantes o los calcioantagonistas.
 - C) Administrar Atropina a los pacientes trasplantados cardíacos.
 - D) Considerar administrar Aminofilina para la bradicardia causada por un infarto de miocardio inferior, un trasplante cardíaco o una lesión medular.
- 23 Un niño de 7 años es trasladado al Servicio de Urgencias por sus padres, varios minutos después de caer a través de una ventana. Presenta sangrado profuso por una herida de 6 cm localizada en la región media del muslo derecho. El manejo inmediato de la herida consiste en:**
- A) Aplicar presión directa en la arteria femoral a nivel de la ingle.
 - B) Aplicar un torniquete.
 - C) Desbridar el tejido desvitalizado.
 - D) Compresión manual directa.

24 ¿Cuál de las siguientes características, en la exploración física, NO suele estar presente en un paciente con sospecha de shock?

- A) Palidez y frialdad cutánea.
- B) Oliguria (diuresis < 0,5 mL/kg/h).
- C) Relleno capilar menor de 2 segundos.
- D) Alteración del estado de conciencia (obnubilación, confusión).

25 Paciente varón de 57 años que consulta en el Servicio de Urgencias por sufrir, de madrugada, dolor epigástrico súbito asociado a náuseas y vómitos de sangre, con deposiciones melénicas. Niega toma de antiinflamatorios no esteroideos de forma habitual. ¿Cuál de las siguientes actuaciones NO estaría indicada?

- A) Colocar de forma rutinaria una sonda nasogástrica para lavados con suero frío.
- B) Canalizar 2 vías periféricas de calibre grueso, que permitan la infusión rápida.
- C) Reponer la volemia con cristaloides.
- D) Solicitar sangre en reserva (al menos 2 concentrados de hematíes).

26 En relación con el reinicio de tratamiento antiagregante y anticoagulante tras hemorragia digestiva aguda gastrointestinal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) En los pacientes con doble tratamiento antiagregante, se recomienda mantener la antiagregación con ácido acetilsalicílico y suspender el clopidogrel durante un periodo corto de tiempo, ya que esto no aumenta significativamente el riesgo de complicaciones cardiovasculares.
- B) Se recomienda reiniciar el tratamiento anticoagulante en pacientes con riesgo tromboembólico bajo en los primeros 3 días después del episodio hemorrágico.
- C) En los pacientes con estigmas de hemostasia reciente, puede reiniciarse el tratamiento antiagregante de forma segura a partir del tercer día después de la endoscopia.
- D) Los pacientes con un riesgo tromboembólico moderado o alto, son los que se podrían beneficiar del reinicio más precoz de la anticoagulación.

27 Paciente de 72 años con implante de marcapasos una semana antes de la asistencia en Urgencias. Acude consultando por mareos y palpitaciones ocasionales. No síncope. No disnea. No dolor torácico. Se ingresa con monitorización electrocardiográfica, que se muestra en la siguiente imagen:



¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico correcto?

- A) Fallo de captura ventricular
- B) Fallo de estimulación.
- C) Infradetección.
- D) Marcapasos normofuncionante.

- 28 Acude a Urgencias un paciente con historia previa de ingesta habitual de alcohol que presenta deterioro clínico importante, ascitis a tensión, ictericia y cuadro clínico de encefalopatía hepática, sin diagnóstico previo conocido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?**
- A) No se debe realizar paracentesis evacuadora, tan solo diagnóstica, hasta obtener el diagnóstico etiológico de la hepatopatía del paciente.
 - B) Solo se debe realizar la paracentesis una vez descartada la PBE (peritonitis bacteriana espontánea), por el riesgo de diseminación.
 - C) Hasta obtener un diagnóstico específico de la hepatopatía, no se debe realizar paracentesis evacuadora, ante el riesgo de enfermedad que contraindique la paracentesis.
 - D) Se debe realizar paracentesis diagnóstica por ser un primer episodio de ascitis, y además evacuadora si la situación clínica del paciente así lo precisa.
- 29 De los siguientes, ¿cuál es un criterio electrocardiográfico mayor de alto riesgo en un paciente con síncope?**
- A) Patrones atípicos de Brugada.
 - B) Bradicardia sinusal asintomática.
 - C) Bloqueo AV de segundo grado Mobitz II o de tercer grado.
 - D) Ondas epsilon sugestivas de miocardiopatía arritmogénica ventricular derecha.
- 30 ¿Cuál de las siguientes pruebas de imagen NO está indicada para el estudio de un posible cuerpo extraño a nivel esofágico?**
- A) Radiografía anteroposterior y lateral de cuello con técnica de partes blandas.
 - B) Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.
 - C) Tomografía computarizada.
 - D) Estudio radiológico con bario.
- 31 En el diagnóstico radiológico de la obstrucción intestinal, ¿cuál de las siguientes asociaciones NO es correcta?**
- A) Asas distendidas de localización periférica, con evidencia de haustras, sugiere obstrucción de intestino grueso.
 - B) El signo del asa centinela sugiere la presencia de un vólvulo.
 - C) La presencia de aerobilia, con o sin cálculo, generalmente de localización en la válvula ileocecal, junto a niveles hidroaéreos de localización central, sugieren íleo biliar.
 - D) Asas distendidas de localización central, con válvulas o pliegues de Kerckring y ausencia de gas en colon y recto, sugieren obstrucción de intestino delgado.
- 32 Con respecto a los criterios de gravedad de pancreatitis aguda, según BISAP (Beside Index of Severity in Acute Pancreatitis), ¿cuál de los siguientes es FALSO?**
- A) Edad mayor de 50 años.
 - B) Disminución del estado de conciencia.
 - C) Presencia de derrame pleural en la radiografía de tórax.
 - D) Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica definido por la presencia de dos o más de los siguientes criterios: FC > 90 lpm; temperatura > 38°C o < 36°C; FR > 20 rpm o PaCO₂ inferior a 32 mmHg; leucocitos > 12.000 o inferior a 4.000, o más de un 10% de cayados.

33 En el taponamiento cardiaco ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) El diagnóstico siempre se debe realizar a través de pruebas de imagen, como la Resonancia Nuclear Magnética o la Tomografía Axial Computarizada.
- B) Ante la sospecha de taponamiento, se debe hacer un ecocardiograma para evaluar el tamaño, la localización y el impacto hemodinámico.
- C) La pericardiocentesis guiada por ecocardiograma es la técnica de elección habitual para el drenaje.
- D) El abordaje quirúrgico se reserva para cuatro situaciones: disección aórtica tipo A, rotura de pared libre tras infarto de miocardio, traumatismo torácico grave y reciente, y hemopericardio iatrogénico cuando el sangrado no se pueda controlar por acceso percutáneo.

34 Dentro de los síntomas clásicos del derrame pericárdico se encuentran todos los siguientes, EXCEPTO:

- A) Fiebre.
- B) Disnea de esfuerzo.
- C) Ortopnea.
- D) Dolor torácico.

35 En un paciente con clínica de dolor torácico asociado a roce pericárdico, elevación del segmento ST y derrame pericárdico, junto con elevación de marcadores de daño miocárdico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) Se recomienda la Resonancia Magnética cardiaca para confirmar afección miocárdica.
- B) Se recomienda hospitalización para el diagnóstico y la monitorización de los pacientes con afección miocárdica.
- C) La afección miocárdica en la pericarditis tiene mal pronóstico, y evoluciona hacia insuficiencia cardiaca o muerte.
- D) Los corticoides se prescriben como segunda opción en casos de contraindicación, intolerancia o fracaso del AAS o los AINE.

36 En paciente con diagnóstico de hepatopatía crónica asociada a hipertensión portal, que acude a Urgencias por presentar cambios de la personalidad o disminución de la memoria, desorientación temporoespacial, bradipsiquia y asterixis, ¿cuál es el grado de encefalopatía en el que podemos clasificar al paciente?

- A) Encefalopatía grado I.
- B) Encefalopatía grado II.
- C) Encefalopatía grado III.
- D) Encefalopatía grado IV.

37 En el paciente con cirrosis hepática, señale la respuesta verdadera:

- A) Los diuréticos recomendados incluyen Espironolactona, de 50 a 200 mg/día, y Amilorida, de 5 a 10 mg/día.
- B) La Lactulosa es la base del tratamiento para la encefalopatía hepática, y se administra por vía oral o bien, por sonda nasogástrica.
- C) El Acetaminofeno se puede usar para aliviar el dolor a corto plazo, a una dosis reducida de 2 g en total por día.
- D) Todas las anteriores son verdaderas.

- 38 En el tratamiento de la diarrea aguda en el niño, solo una de las medidas propuestas es correcta:**
- A) Hay que recomendar una dieta astringente pobre en fibra hasta su resolución.
 - B) Se recomienda la retirada de la lactancia materna en los lactantes.
 - C) Se debe recomendar rehidratación oral durante 4-6 horas, y realimentación posterior con dieta normal evitando los períodos prolongados de ayuno.
 - D) Se recomienda reducir de entrada el aporte de lactosa los primeros días de la diarrea.
- 39 Con respecto a la definición de síncope, señale la respuesta FALSA:**
- A) El síncope es consecuencia de una caída de la presión arterial sistémica con reducción general del flujo sanguíneo cerebral.
 - B) Se caracteriza por amnesia durante el periodo de inconsciencia, control motor anómalo, falta de respuesta y duración corta.
 - C) El síncope se origina como consecuencia de una actividad cerebral excesivamente anormal.
 - D) La recuperación del síncope se produce de forma espontánea.
- 40 En el tratamiento del edema agudo de pulmón, ¿cuál de los siguientes NO corresponde a uno de los tres pilares básicos?**
- A) El oxígeno, administrado como presión positiva continua en las vías respiratorias, ventilación con presión positiva no invasiva y/o cánula nasal de alto flujo.
 - B) La Dopamina, como tratamiento vasopresor de primera línea en caso de edema agudo de pulmón con gasto cardíaco bajo.
 - C) El tratamiento con diuréticos intravenosos (iv).
 - D) El tratamiento con vasodilatadores iv si la presión arterial sistólica es alta.
- 41 En el diagnóstico diferencial del dolor abdominal en niños, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?**
- A) La torsión testicular/ovárica es la patología quirúrgica más frecuente en edad escolar.
 - B) En las niñas en edad puberal, se debe incluir siempre un test de embarazo.
 - C) En la invaginación intestinal nunca se objetivan productos patológicos (sangre o moco) en las heces.
 - D) La TAC abdominal es la prueba de imagen a realizar de forma rutinaria en todo proceso abdominal del niño.
- 42 En relación con las dosificaciones de fármacos en pediatría, ¿cuál de las siguientes respuestas es FALSA?**
- A) Debería utilizarse, siempre que sea posible, la vía de administración menos cruenta.
 - B) Debemos esperar al diagnóstico etiológico antes de iniciar el tratamiento analgésico.
 - C) Se debe reevaluar el efecto y cambio en la intensidad del dolor tras 30-60 minutos de administrar el analgésico.
 - D) Si en la reevaluación del dolor no se objetiva mejoría, valorar cambiar la pauta escogida.

- 43 Entre los aspectos más destacados en soporte vital avanzado, según las Guías Clínicas del ERC 2021, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?**
- A) La prioridad son las compresiones torácicas de alta calidad con las mínimas interrupciones, la desfibrilación precoz, y el tratamiento de las causas reversibles.
 - B) Los pacientes con parada cardíaca, tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria, no presentan signos premonitorios.
 - C) Administrar adrenalina de forma precoz para la parada cardíaca no desfibrilable.
 - D) Utilice técnicas de vía aérea básica o avanzada. Solo los reanimadores con una elevada tasa de éxito deben intentar la intubación traqueal.
- 44 ¿Cuál de estos factores se considera de riesgo para infección por enterobacterias productoras de BLEE (β -lactamasas de espectro extendido)?**
- A) Edad > de 65 años.
 - B) Hipertensión arterial.
 - C) Tratamiento antibiótico en los 12 meses previos.
 - D) Ser personal sanitario.
- 45 En cuanto a los biomarcadores de infección que usamos en Urgencias, señale la respuesta FALSA:**
- A) La Proteína C Reactiva (PCR) comienza a aumentar a las 6-8 horas después del inicio de la infección, y alcanza su valor máximo a las 36-48 horas.
 - B) La insuficiencia renal crónica puede producir un aumento de la Procalcitonina.
 - C) En el shock séptico, un aclaramiento de los niveles de Lactato de <10% en las 6 primeras horas, es un dato de buen pronóstico.
 - D) A diferencia de la PCR, la Procalcitonina no se modifica con la administración de corticoides.
- 46 En el síndrome febril en paciente usuario de drogas vía parenteral (UDVP), señale la respuesta FALSA:**
- A) La fiebre puede deberse a pirógenos exógenos.
 - B) La endocarditis puede tratarse asociando cloxacilina y gentamicina.
 - C) La hepatitis aguda en UDVP precisa tratamiento con cefalosporinas.
 - D) La meningitis tuberculosa no es infrecuente en UDVP.
- 47 ¿Qué puntuación en la escala qSOFA adjudicaríamos a un paciente con una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una presión arterial sistólica de 105 mmHg y una puntuación en la escala de Glasgow de 13/15?**
- A) 0 puntos.
 - B) 1 punto.
 - C) 2 puntos.
 - D) 3 puntos.

- 48 NO usaremos como antibioterapia empírica en el shock séptico de foco desconocido:**
- A) Meropenem + Daptomicina.
 - B) Imipenem + Vancomicina.
 - C) Imipenem + Metronidazol.
 - D) Meropenem + Vancomicina + Amikacina.
- 49 Indique cuál de los siguientes valores NO usamos en el cálculo de la escala SOFA en los pacientes sépticos:**
- A) Escala de Glasgow.
 - B) Plaquetas.
 - C) Saturación de oxígeno en pulsioximetría.
 - D) Creatinina.
- 50 Ante un caso de meningitis o encefalitis, es FALSO que:**
- A) Tras diagnóstico de meningitis, debemos realizar profilaxis de los contactos con Rifampicina o Ciprofloxacino en caso de infección por Neisseria meningitidis.
 - B) La punción lumbar ha de ir precedida por prueba de imagen (TAC) en un paciente que previamente haya convulsionado.
 - C) Consideramos un líquido cefalorraquídeo con celularidad normal si no contiene más de 15 células/ μ L.
 - D) Ante una encefalitis herpética, se recomienda el tratamiento con Aciclovir en dosis de 10-15 mg/kg/hora,
- 51 Para reducir la probabilidad de aparición de resistencias bacterianas, NO se recomienda:**
- A) Disminuir la prescripción de antimicrobianos y, en su caso, la duración de los tratamientos más allá del tiempo necesario.
 - B) Asociar varios antimicrobianos para un tratamiento bactericida más eficaz.
 - C) Ajustar el espectro a la sospecha etiológica, evitando en lo posible la utilización de antimicrobianos de amplio espectro.
 - D) Establecer una terapia de simplificación y secuencial precoces.
- 52 En las neumonías adquiridas en la comunidad (NAC), señale la respuesta FALSA:**
- A) En el tratamiento ambulatorio de la NAC podemos considerar el uso por vía oral de Cefditoreno (400 mg/12h) o Amoxicilina (1 g/8h) o Amoxicilina-clavulánico (875 mg/125 mg/8h).
 - B) En el tratamiento de la neumonías por mecanismo aspirativo, podemos considerar el uso de Amoxicilina-clavulánico (intravenoso) iv (2 g/8h) o Claritromicina iv (500 mg/12h).
 - C) En las NAC graves, con factores de riesgo de infección por Staphylococcus aureus, consideraremos añadir Linezolid (600 mg/12h).
 - D) En las neumonías con sospecha de infección por Pseudomona, consideraremos el tratamiento con Cefepime iv (2 g/12h) o Meropenem iv (1 g/8h) o Piperacilina-Tazobactam iv (4/0,5 g/6-8h).

53 En relación con las infecciones de transmisión sexual, es FALSO que:

- A) La lesión por lúes, en la mayoría de los casos, es única y generalmente indolora.
- B) El tratamiento de elección de la sarna es Permetrina al 2%.
- C) El tratamiento empírico de una proctitis puede ser 1 gr de Ceftriaxona en dosis única + 1 gr Azitromicina oral.
- D) La gonococia suele producir úlceras múltiples y dolorosas.

54 Respecto al tétanos, indique qué afirmación es la INCORRECTA:

- A) El periodo de invasión se caracteriza por raquialgia, insomnio, trismus y alteración del nivel de conciencia.
- B) Es una Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO).
- C) Se puede usar Labetalol en el tratamiento de la disfunción autonómica.
- D) El tétanos generalizado es la forma clínica más frecuente y severa.

55 En la sepsis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- A) La administración precoz de antibioterapia empírica es esencial en el pronóstico del paciente con sepsis o shock séptico.
- B) Si el paciente es portador de catéter intravascular, esperaremos estabilización hemodinámica y a localizar el foco para su retirada.
- C) La terapia de alto flujo es preferible a la ventilación no invasiva, y más efectiva que la oxigenoterapia convencional.
- D) Los fármacos vasopresores suelen ser inefectivos si no se ha corregido previamente la hipovolemia.

56 En las consideraciones a tener en cuenta en el diagnóstico precoz de VIH oculto en los servicios de Urgencias, señale la respuesta FALSA:

- A) El síndrome mononucleósico presenta alta prevalencia como una condición indicadora de VIH, y una elevada frecuentación en Urgencias.
- B) El herpes zóster es 15 veces más frecuente en personas con VIH que en la población general.
- C) En Urgencias, no es necesario el consentimiento verbal del paciente para realizarle serología para VIH.
- D) La prevalencia del VIH en Urgencias es mayor que en la población general.

57 ¿Cuál es la principal complicación de la infección por el virus de la varicela-zóster en adultos?

- A) Conjuntivitis.
- B) Neumonía.
- C) Miocarditis.
- D) Hepatitis.

58 En la exploración de una sordera brusca unilateral neurosensorial (de percepción), señale la respuesta correcta:

- A) Rinne (-) en oído enfermo y Weber lateralizado al oído sano.
- B) Rinne (-) en oído enfermo y Weber lateralizado al oído enfermo.
- C) Rinne (+) en oído enfermo y Weber lateralizado al oído sano.
- D) Rinne (+) en oído enfermo y Weber lateralizado al oído enfermo.

- 59 En el traumatismo craneoencefálico, según el Proceso Asistencial Integrado (PAI) de la Atención al Trauma Grave (2ª edición, 2020), ¿qué factor de riesgo determina hacer un Tomografía Computarizada craneal en la primera hora?**
- A) Más de un episodio de vómitos.
 - B) Edad > 65 años.
 - C) Tratamiento con anticoagulantes orales.
 - D) Caída desde una altura > 1 metro.
- 60 En relación con los objetivos terapéuticos generales en la atención al paciente con traumatismo craneoencefálico grave, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Saturación de O₂ > 95%.
 - B) Presión arterial sistólica > 90 mmHg.
 - C) Hemoglobina > 10 g/dl.
 - D) Tiempo de protrombina > 60%.
- 61 En la fractura de calcáneo, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) El signo más precoz es la equimosis.
 - B) Las proyecciones radiográficas lateral y axial de calcáneo son las de elección.
 - C) El tratamiento quirúrgico está indicado si hay aplanamiento del calcáneo.
 - D) La atrofia de Sudeck es una complicación de esta fractura.
- 62 En el tratamiento de la preeclampsia grave, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Sondaje vesical con medición diuresis horaria.
 - B) Control de la presión arterial cada 5 minutos hasta su estabilización.
 - C) El objetivo es conseguir una presión arterial sistólica por debajo de 180 mmHg.
 - D) Está indicada la administración de fármacos hipotensores, como el Labetalol.
- 63 En el traumatismo abdominal cerrado con inestabilidad hemodinámica, señale la prueba diagnóstica prioritaria:**
- A) Ecografía FAST.
 - B) Punción lavado peritoneal.
 - C) Tomografía Axial computarizada de abdomen.
 - D) Arteriografía.
- 64 Respecto a la inervación de los segmentos espinales y su relación con los reflejos, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Segmento L1/L2 – Reflejo cremastérico.
 - B) Segmento L2/L3 – Reflejo rotuliano.
 - C) Segmento L3/L4 – Reflejo aquileo.
 - D) Segmento L5/S1 – Reflejo anal.
- 65 En la luxación acromioclavicular tipo IV (clasificación de Rockwood y Matsen), señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Rotura de ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares.
 - B) Rotura de deltoides.
 - C) Rotura de trapecio.
 - D) Luxación anteroinferior.

66 En la intoxicación aguda por digitálicos, señale la respuesta correcta:

- A) La dosis tóxica es > 2 ng/ml.
- B) La hiperpotasemia y la hiponatremia favorecen la intoxicación.
- C) La administración de carbón activado está contraindicada.
- D) En las bradiarritmias sintomáticas, está contraindicada la Atropina.

67 En el tratamiento del dolor oncológico, señale la respuesta correcta:

- A) La vía prioritaria es la subcutánea o intravenosa.
- B) La Codeína es un fármaco del primer escalón terapéutico.
- C) La Oxicodona tiene una potencia analgésica algo inferior a la de la Morfina.
- D) El Tapentadol es útil en el dolor nociceptivo y neuropático.

68 En la emesis aguda posquimioterapia del paciente oncológico, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Es la que comienza durante las primeras 24 horas de haber iniciado el ciclo de quimioterapia.
- B) El tratamiento depende de la profilaxis antiemética utilizada, de la quimioterapia administrada y del tiempo transcurrido desde la misma.
- C) La Metoclopramida es la primera opción, si se ha realizado la profilaxis antiemética.
- D) Los fármacos antiserotoninérgicos (Granisetrom, Ondasetrom) están indicados en el tratamiento agudo.

69 En el traslado de pacientes críticos, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Debe mantenerse una comunicación fluida entre el equipo asistencial y el conductor o piloto.
- B) La ambulancia está indicada cuando la distancia prevista no supere los 150 km.
- C) El helicóptero está indicado cuando el traslado terrestre sea superior a 90 minutos.
- D) El helicóptero está indicado cuando la distancia prevista no supere los 1.000 km.

70 En el volet costal (tórax inestable), señale la respuesta correcta:

- A) Es la fractura de dos o más costillas, en dos o más puntos.
- B) Su gravedad depende principalmente de la deformidad torácica.
- C) Las alteraciones radiológicas predicen el grado de contusión pulmonar.
- D) El tratamiento analgésico no mejora la hipoxia del paciente.

71 En el cólico del lactante, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Irritabilidad y llanto excesivo vespertino.
- B) Aparece en el primer trimestre de vida.
- C) El tratamiento se basa en analgésicos.
- D) Es un proceso benigno.

72 En la fractura abierta grado III, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Tiene un diámetro de 5 cm y hay lesión de partes blandas.
- B) Requiere lavado de la herida con solución salina fisiológica.
- C) No debe suturarse la piel por lo menos en las primeras 48 horas.
- D) Está indicada la administración de Cefazolina y aminoglucósidos.

- 73 Respecto a las indicaciones de la intubación endotraqueal y ventilación mecánica, según el PAI de la Atención al Trauma Grave (2ª edición, 2020), señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Neumotórax a tensión.
 - B) Traumatismo craneoencefálico grave con puntuación en escala de Glasgow < 9.
 - C) Inestabilidad hemodinámica persistente (presión arterial sistólica < 90 mmHg).
 - D) Traumatismo torácico, insuficiencia respiratoria grave (frecuencia respiratoria > 29 ó < 6).
- 74 En las fracturas de pelvis (“en libro abierto”), señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Es una fractura tipo b1 (clasificación de Tile).
 - B) Si hay hematuria, hay que descartar una rotura uretral.
 - C) La cirugía está indicada si sínfisis abierta más de 1 cm.
 - D) La hipovolemia es una complicación de este tipo de fracturas.
- 75 En el tratamiento inicial del paciente agitado, señale la respuesta correcta:**
- A) La contención física es la primera opción.
 - B) Las benzodicepinas están indicadas en la abstinencia alcohólica.
 - C) Los neurolépticos de primera generación son de elección en el paciente anciano.
 - D) Debe evitarse la combinación de Midazolam con Haloperidol.
- 76 Una de estas correlaciones tóxico-antídoto es INCORRECTA:**
- A) Bloqueantes beta – Glucagón.
 - B) Etilenglicol - Etanol.
 - C) Organofosforados – Adrenalina.
 - D) Opiáceos – Naloxona.
- 77 Respecto a los factores de laboratorio de progresión grave de COVID-19, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Saturación de oxígeno < 88%.
 - B) Linfocitopenia.
 - C) Trombocitosis.
 - D) Incremento de las troponinas séricas.
- 78 Respecto a la colocación del collarín cervical en el paciente politraumatizado, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Se realiza antes que la valoración de la permeabilidad de la vía aérea.
 - B) Es ideal que disponga de apoyo mentoniano.
 - C) Es ideal que disponga de apertura para el acceso emergente de la vía aérea.
 - D) Es ideal que disponga de apertura occipital que permita la valoración de la parte posterior del cuello.

79 En la intoxicación aguda por cáusticos, señale la respuesta correcta:

- A) El dolor faríngeo es el síntoma más frecuente.
- B) La endoscopia digestiva alta debe realizarse en las primeras 12 horas.
- C) La administración de carbón activado está formalmente indicada.
- D) La colocación de una sonda nasogástrica está contraindicada en las quemaduras de segundo o tercer grado.

80 Tras alcanzar la fase de estabilidad clínica de la agudización de la EPOC, el tratamiento broncodilatador de continuación requiere la asociación de varios fármacos. Indique la combinación INCORRECTA:

- A) Salmeterol, Olodaterol, Fluticasona.
- B) Glicopirronio, Formoterol, Budesonida.
- C) Glicopirronio, Formoterol, Beclometasona.
- D) Umeclidino, Vilanterol, Fluticasona.

81 Dentro de los criterios de ingreso en la UCI de un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad (NAC), indique cuál de los siguientes NO se considera un criterio menor:

- A) Frecuencia respiratoria superior a 30 rpm.
- B) Leucocitopenia menor 4.000/ μ L.
- C) Hipotermia con temperatura central inferior a 36°C.
- D) Hipertensión arterial con necesidad de tratamiento hipotensor urgente.

82 Señale la aseveración ERRÓNEA respecto la hemoptisis:

- A) La radiografía de tórax puede ser normal en el 25-30% de los casos.
- B) Si la saturación periférica de oxígeno es inferior al 95% debe de realizarse gasometría arterial, estando indicada siempre antes de la realización de una broncoscopia.
- C) La broncoscopia es la exploración más eficaz, y tiene utilidad tanto diagnóstica como terapéutica.
- D) Los pacientes con hemoptisis, en quienes no se encuentra la causa después de realizar la broncoscopia y la tomografía computerizada de alta de resolución (TCAR) de tórax, tienen un pronóstico infausto.

83 En relación a los inhibidores de la P2Y₁₂, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) El Clopidogrel es el antiagregante de primera elección para administrarlo junto con el AAS.
- B) El Ticagrelor debe de utilizarse con precaución en pacientes con EPOC y asma severos, bloqueo aurículo-ventricular y disfunción sinusal.
- C) El Prasugrel se debe de utilizar con precaución en paciente > 75 años, < 60 kg de peso, y está contraindicado en ictus o AIT previos.
- D) Tanto Prasugrel como Ticagrelor están contraindicados si existe un alto riesgo hemorrágico.

- 84 Un paciente en coma con presencia de respiración de Cheyne-Stokes, ¿en qué nivel situaría la lesión?**
- A) Lesión bulbar.
 - B) Lesión mesencefálica o protuberancial alta.
 - C) Lesión protuberancial baja.
 - D) Lesión diencefálica o hemisférica bilateral de origen estructural o metabólico.
- 85 Indique qué afirmación es FALSA con respecto a la fibrinólisis intravenosa en el ictus isquémico:**
- A) La principal complicación del tratamiento con rt-PA o Alteplasa (activador tisular del plasminógeno recombinante) es la transformación hemorrágica sintomática.
 - B) En la actualidad el uso de rt-PA intravenoso dentro de las 3 primeras horas, se recomienda con un máximo nivel de evidencia por la European Stroke Organization y la American Heart Association / American Stroke Association, y sigue ofreciendo beneficio en las primeras 4.5 horas en pacientes seleccionados.
 - C) La aparición de angioedema por rt-PA suele aparecer al final de la infusión del rt-PA y se resuelve en menos de 24h.
 - D) La dosis de rt-Pa es de 10 mg/kg hasta un máximo de 100 mg.
- 86 ¿Cuál de los siguientes parámetros NO aparece en una crisis asmática de riesgo vital (Nivel I)?**
- A) Estado de conciencia confuso.
 - B) Frecuencia respiratoria mayor 30 rpm.
 - C) Abundantes y fuertes sibilancias.
 - D) Uso de fármacos betaadrenérgicos sin respuesta.
- 87 Ante un paciente con disnea de reposo, sibilancias fuertes y abundantes, incremento de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca superior a 110 latidos/minuto y saturación periférica de oxígeno respirando aire ambiente inferior al 92%, ¿cómo catalogaría el grado de gravedad de esta crisis asmática?**
- A) Leve.
 - B) Moderada.
 - C) Grave.
 - D) Riesgo vital.
- 88 La EPAP (presión espiratoria positiva) mejora la situación clínica en el fallo respiratorio agudo por todos los siguientes efectos, MENOS UNO. Márquelo.**
- A) Mejora la oxigenación (presión parcial de O₂).
 - B) Disminuye el trabajo respiratorio y el retraso en la inspiración en pacientes con autoPEEP (aumento de presión alveolar en relación con la hiperinsuflación dinámica).
 - C) Aumento del gasto cardíaco y del retorno venoso.
 - D) Disminuye la frecuencia respiratoria sin disminuir el volumen minuto.

- 89 De las siguientes aseveraciones respecto al tratamiento de la hipocalcemia aguda sintomática, indique la respuesta INCORRECTA:**
- A) Se trata con Gluconato Cálcico por vía intravenosa.
 - B) Es preferible la administración de Gluconato Cálcico, ya que la extravasación accidental de Cloruro Cálcico puede producir necrosis tisular.
 - C) El Gluconato Cálcico se puede administrar conjuntamente con bicarbonato sódico si existiese acidosis metabólica asociada.
 - D) Simultáneamente se administra Calcio por vía oral asociado a Calcitriol.
- 90 ¿Cuál de los siguientes fármacos NO forma parte del tratamiento de la hiperpotasemia moderada?**
- A) Solución glucosada hipertónica con Insulina.
 - B) Gluconato Cálcico.
 - C) Bicarbonato Sódico 1 M.
 - D) Furosemida.
- 91 Varón de 37 años que cursa con cefalea unilateral, intensa y localizada a nivel supraorbitario, de 15 a 45 minutos de duración, y que se le presentan de 1 a 8 veces al día. Los ataques se acompañan de inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, sudoración facial y miosis, estrictamente en región izquierda. ¿Qué diagnóstico es el más probable?**
- A) Cefalea hemicránea paroxística.
 - B) Neuralgia del trigémino.
 - C) Cefalea en racimos.
 - D) Cefalea punzante idiopática.
- 92 Mujer de 58 años que acude a Urgencias presentando diplopia al mirar en ciertas direcciones, ptosis parpebral y midriasis unilateral arreactiva. A la exploración del ojo derecho, no puede moverse hacia arriba, ni hacia abajo ni hacia dentro. Al realizar la TC craneal aparece una lesión compatible con un aneurisma. Indique la estructura afectada:**
- A) III par craneal derecho.
 - B) IV par craneal derecho.
 - C) III par craneal izquierdo.
 - D) IV par craneal izquierdo.
- 93 Varón de 82 años que acude a Urgencias presentando fiebre, disminución del nivel de conciencia, confusión mental, mioclonías, crisis epilépticas y disfasia. La TAC craneal presenta en región occipital izquierda 2 pequeñas lesiones isquémicas de perfil crónico, sin imágenes de sangrado, y el líquido cefalorraquídeo ha mostrado una pleocitosis linfocitaria moderada. El diagnóstico más probable es:**
- A) Meningitis bacteriana.
 - B) Encefalitis viral.
 - C) Enfermedad de Creutzfeldt Jakob.
 - D) Síndrome de Ramsay Hunt.

- 94 Ante un estatus epiléptico establecido, ¿cuál de estos fármacos NO considera de segunda elección?**
- A) Levetiracetam.
 - B) Lacosamida.
 - C) Valproato.
 - D) Fenobarbital.
- 95 Tras la realización de una espirometría después de la inhalación de broncodilatadores a un paciente con EPOC, se detecta un volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) de un 70%. ¿Qué grado funcional corresponde?**
- A) Grado I.
 - B) Grado II.
 - C) Grado III.
 - D) Grado IV.
- 96 Indique la respuesta FALSA en relación con la medicación de control que se utiliza para el tratamiento después de una crisis asmática:**
- A) Los agonistas betaadrenérgicos de acción prolongada pueden administrarse en monoterapia o asociados a corticoides inhalados.
 - B) Los corticoides inhalados como monoterapia solo están indicados en la crisis leve con buena respuesta terapéutica.
 - C) El uso de dispositivos que combinan, en dosis fijas, un corticoide inhalado y un betaadrenérgico de acción prolongada, mejora el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente y el control de la enfermedad.
 - D) Una pauta corta de corticoides está indicada incluso en las crisis leves, ya que proporciona una mejoría rápida y evita recaídas.
- 97 En relación a los modos ventilatorios en Ventilación No Invasiva, indique la respuesta correcta:**
- A) Los modos ventilatorios más usados son los controlados por volumen.
 - B) A diferencia de la ventilación invasiva, las resistencias en la vía aérea superior son variables.
 - C) El modo más utilizado es el de dos niveles de presión ciclado por tiempo.
 - D) La ventilación proporcional asistida es un modo cada vez más utilizado.
- 98 Ante el resultado del análisis de un líquido pleural, ¿cuál de las siguientes características NO se corresponde con un exudado?**
- A) pH inferior a 7,30.
 - B) Proteínas superiores a 3 g/dl.
 - C) Lactato deshidrogenasa superior a 200 UI/ml.
 - D) Glucosa en líquido pleural igual o similar a la sérica.

99 Durante la fase aguda de una agudización de la EPOC, ¿qué fármaco de los siguientes NO estaría indicado de manera sistemática?

- A) Salbutamol.
- B) Teofilina.
- C) Bromuro de Ipratropio.
- D) Terbutalina.

100 Dentro de los criterios diagnósticos del MINOCA (Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries), indique la respuesta INCORRECTA:

- A) Detección de, al menos, un valor elevado de troponina por encima del percentil 99.
- B) Alteraciones en el segmento ST.
- C) Angiografía con lesiones significativas (> 50%).
- D) Ausencia de otros procesos que producen daño miocárdico.

APES_MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA 2023 / TURNO LIBRE

CUESTIONARIO PRÁCTICO

CASO PRÁCTICO 1:

Paciente varón de 78 años, traído al Servicio de Urgencias hospitalario por un Equipo Móvil del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, con disnea intensa, cianosis generalizada, tiraje supraclavicular, Presión Arterial (PA) 190/110 mmHg, Frecuencia Cardíaca (FC) 130 sístoles por minuto (spm), Frecuencia Respiratoria 30 respiraciones por minuto (rpm), Saturación de oxígeno (Sat O₂) 80%. Auscultación respiratoria con sibilantes en mitad de campos superiores y crepitantes basales. Antecedentes Personales: Diabetes Mellitus, EPOC Gold II, Hipertensión Arterial, Valvulopatía mitral. Tratamiento habitual: Gliclazida 30 mg por vía oral (pvo)/24h, Metformina 850 mg pvo/8h, Carvedilol 25 mg pvo/24h, Amlodipino 10 mg/Olmesartan 40 mg pvo cada 24 h, Seretide 50/500mcg 1 inhalación (inh)/12h y Tiotropio 2 inh/24 h.

101 ¿Con qué terapia NO iniciaría el tratamiento de este paciente?

- A) Corticoides intravenoso (iv).
- B) Diuréticos iv.
- C) Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI).
- D) Vasodilatadores iv.

102 La gasometría arterial muestra pH 7,30, PCO₂ 80 mmHg, PO₂ 56 mmHg, SatO₂ 85%.

¿Cuál sería la terapia respiratoria inicial?

- A) CPAP con presión de 10 cmH₂O.
- B) Oxigenoterapia en Reservoirio a 15 litros por minuto, FiO₂ 90%.
- C) BiPAP con parámetros IPAP 14 cmH₂O y EPAP 5 cmH₂O.
- D) Intubación endotraqueal.

103 Señale la exploración complementaria que aporta más valor al diagnóstico de este paciente:

- A) Radiología de tórax.
- B) NT-proBNP.
- C) Ecocardiografía.
- D) Dímero D.

104 El paciente presenta Presión Arterial Sistólica (PAS) de 90 mmHg y está sudoroso, con frialdad distal y pulso filiforme. ¿Qué tratamiento farmacológico está indicado iniciar?

- A) Amiodarona.
- B) Calcioantagonistas.
- C) Noradrenalina.
- D) Dopamina.

105 En relación al tratamiento, si el paciente continúa con PAS < 90 mmHg, indique la respuesta FALSA:

- A) El Cloruro Mórfo se debe evitar, ya que se asocia con una mayor frecuencia de ventilación mecánica, hospitalización prolongada, más ingresos en la unidad de cuidados intensivos y mayor mortalidad.
 - B) Administrar diuréticos a dosis bajas, e incrementar según respuesta del paciente.
 - C) Estaría indicado administrar un bolo intravenoso de inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 3 o Levosimendán.
 - D) Está indicado tratamiento con fármacos inotrópicos.
-

CASO PRÁCTICO 2:

Se trata de una mujer de 68 años de edad, con oxigenoterapia crónica domiciliar a 1,5 litros/minuto (l/min) durante 24 horas al día, que atendemos en su domicilio. La paciente refiere presentar empeoramiento súbito de su disnea hasta hacerse de reposo, tendencia al sueño y frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto (rpm). Refiere el familiar que lleva 3 días de evolución con fiebre de hasta 38,5°C, aumento de la tos y de la expectoración, que es más espesa y de coloración verdosa. Revisando su historia clínica, encontramos una espirometría realizada en su centro de salud hace un mes con los siguientes resultados: el FEV1 (volumen espiratorio forzado en el primer segundo) es de 35% del teórico, y un cociente FEV1/FVC (capacidad vital forzada) postbroncodilatación era de 0,5. También existe registro de una puntuación en la escala de disnea modificada del Medical Research Council (mMRC) de 3 en situación basal, y una puntuación en el cuestionario CAT (COPD Assessment Test) de 11. La paciente refiere clínica similar a la actual hace 11 meses, que no precisó ingreso hospitalario.

106 ¿Cómo clasificaría a esta paciente a partir de los datos de la historia clínica?

- A) EPOC. Grado 3. Grupo E de la Gold (agudizador y sintomático).
- B) EPOC. Grado 3. Grupo B de la Gold (no agudizador y sintomático).
- C) EPOC. Grado 4. Grupo D de la Gold (no agudizador y asintomático).
- D) EPOC. Grado 4. Grupo B de la Gold (no agudizador y sintomático).

107 Respecto a la derivación de este paciente al hospital, ¿qué respuesta es la correcta?

- A) Todas las agudizaciones de EPOC requieren valoración hospitalaria.
- B) En caso de tener una saturación de oxígeno mayor del 92% con gafas nasales a 1,5 l/min, no requiere derivación.
- C) Por ser un EPOC grave ($FEV1 < 50\%$), la agudización requiere asistencia hospitalaria.
- D) La imposibilidad de controlar la enfermedad en domicilio no es un criterio de derivación.

108 Cuando usted explora a la paciente, presenta fiebre de 38,5°C, tensión arterial (TA) de 137/84 mmHg, frecuencia respiratoria de 35 rpm, saturación -con gafas nasales a 1,5 l/min- del 78%, y una auscultación con una disminución generalizada del murmullo vesicular, roncus y sibilancias. Se extrae una gasometría arterial que muestra un pH de 7,36, una PaO_2 de 48, una $PaCO_2$ de 57 y un CO_3H de 28. ¿Qué haría en este momento?

- A) Adecuar el método de oxigenación teniendo en cuenta el trabajo respiratorio y la respuesta de la saturación de la paciente.
- B) Administrar la FiO_2 necesaria para conseguir una saturación por encima del 95%.
- C) Ante el riesgo de COVID-19, siempre usar una mascarilla reservorio durante el traslado.
- D) CPAP a 4 cmH₂O con una FiO_2 del 50%.

109 La paciente ha sido trasladada con mascarilla reservorio al hospital. A su llegada presenta una saturación del 100 %. Se repite la gasometría arterial y presenta un pH de 7,32, una PO_2 107, una PCO_2 de 78 y un CO_3H de 29. Se opta por retirar la mascarilla reservorio y se coloca una mascarilla tipo Venturi con una FiO_2 del 28%. Tras unos minutos, la saturación se mantiene estable en el 82%. Señale la actuación más correcta:

- A) Aumentar la FiO_2 de la mascarilla tipo Venturi por encima del 28% hasta mantener una saturación del 95%.
- B) Aumentar la FiO_2 de la mascarilla tipo Venturi por encima del 28% hasta mantener una saturación del 85-90%.
- C) Colocar una BiPAP con una PS (presión de soporte) menor de 6 cmH₂O.
- D) Colocar una BiPAP con una PS (presión de soporte) al menos de 10 cmH₂O.

110 La paciente, tras tratamiento en observación con corticoides intravenosos, antibiótico y broncodilatadores, ha mejorado clínicamente. Tras 8 horas de estancia en área de observación mantiene saturación del 95% con gafas nasales a 1,5 l/min. En la analítica destaca una leucocitosis de $13.32 \times 10^3/\mu\text{L}$, con un 82% de neutrófilos, y una eosinofilia de $302/\mu\text{L}$. La radiografía de tórax no muestra imágenes de condensación. Con vistas al alta, revisamos su tratamiento broncodilatador previo al ingreso que consistía en un LABA (β_2 -miméticos inhalados de acción prolongada) más un LAMA (anticolinérgicos inhalados de acción prolongada). Señale la respuesta correcta:

- A) Mantener la antibioterapia en domicilio hasta completar la pauta. Añadir un SABA de rescate. Prescribir una pauta de corticoides en descenso.
 - B) Al tratarse de una agudización de origen infeccioso, no prescribir corticoides inhalados por riesgo de neumonía.
 - C) Mantener la antibioterapia en domicilio hasta completar la pauta. Prescribir una pauta oral de Prednisona durante 5-7 días. Añadir un corticoide inhalado a su tratamiento broncodilatador previo y programar una revisión.
 - D) Mantener la antibioterapia en domicilio hasta completar la pauta. Prescribir una pauta oral de Prednisona durante 5-7 días. Añadir un corticoide inhalado a su tratamiento broncodilatador previo durante 30 días y programar una revisión.
-

CASO PRACTICO 3:

Avisan por episodio de dolor torácico en domicilio, en varón de 71 años. A la llegada del equipo de emergencias (13 min), encuentra al paciente postrado en un sillón con una mano en el pecho, pálido y sudoroso, refiriendo dolor centrotorácico opresivo irradiado a brazo izquierdo y náuseas. El hijo comenta que ha comenzado con dicha clínica hace 25 min, mientras veía un partido de fútbol en televisión. Antecedentes Personales: No alergias medicamentosas conocidas. HTA. DM tipo II. Sin cardiopatía previa conocida. Accidente isquémico transitorio (AIT) en 2020 sin secuelas. Tratamiento domiciliario: Ramipril 5 mgr 1 comp/24 horas. Metformina 850 mgr 1 comp/24 horas, AAS (Ácido acetil salicílico) 100 mgr 1 comp/24 horas. Exploración Física: Tensión arterial 178/93 mmHg, Frecuencia cardiaca de 88 lpm (latidos por minuto), Saturación Oxígeno 97% basal. Afebril. Eupneico en reposo con frecuencia respiratoria de 15 rpm (respiraciones por minuto). Consciente, orientado y colaborador, regular estado general. Pálido y sudoroso. Auscultación cardíaca: tonos rítmicos, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. No crepitantes. Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación; no defensa abdominal. Miembros inferiores: no edemas, no signos de TVP (trombosis venosa profunda). Pulsos conservados.

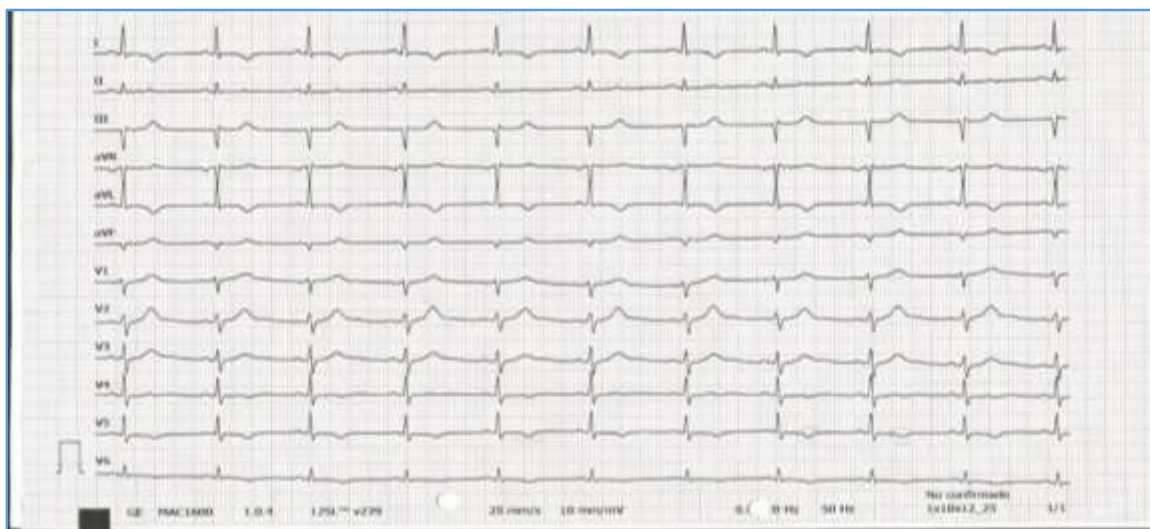
111 ¿Cómo debemos actuar en la primera asistencia con este paciente?

- A) Administrar doble antiagregación de forma inmediata.
- B) Estratificación del riesgo isquémico (GRACE) y hemorrágico (CRUSADE).
- C) Trasladar inmediatamente a Hospital para realización de ECO-cardiografía.
- D) Monitorizar y realizar ECG de 12 derivaciones.

112 Una vez que el paciente es trasladado al Servicio de Urgencias Hospitalario, indique la respuesta FALSA:

- A) Se recomienda realizar un ECG de 12 derivaciones durante los primeros 10 minutos del primer contacto médico, que debe ser interpretado inmediatamente por un médico con experiencia.
- B) Está recomendada la monitorización continua del ritmo hasta que se establezca o se descarte el diagnóstico de IAMSEST (infarto agudo de miocardio con elevación del ST).
- C) Se recomienda usar el algoritmo de 0 hora (h)/1 h de la ESC (European Society of Cardiology), con la obtención de muestras de sangre a las 0 h y 1 h si está disponible la determinación de hs-cTn (troponina cardiaca de alta sensibilidad) con un algoritmo validado de 0 h/1 h.
- D) La ecocardiografía puede sustituir el ECG de 12 derivaciones, estando recomendada para pacientes con parada cardiaca o inestabilidad hemodinámica de origen probablemente cardiovascular.

113 Tras realizar ECG en Urgencias, que se muestra a continuación:



Indique la respuesta FALSA en relación al pretratamiento antiagregante plaquetario:

- A) Está recomendado el pretratamiento de forma rutinaria con un inhibidor del P2Y12 cuando se planea una estrategia invasiva precoz (ICPP intervencionismo percutáneo precoz) en < 24h.
- B) Se puede administrar Ticagrelor independientemente de la estrategia de tratamiento (invasiva o conservadora) a dosis de carga de 180 mg, seguida de 90 mg 2 veces al día.
- C) Se debe considerar el uso de Prasugrel, antes que Ticagrelor, para pacientes con SCASEST que se someten a una ICPP (en menos de 24h).
- D) Dependiendo del riesgo hemorrágico, se puede considerar el pretratamiento con un inhibidor del P2Y12 para pacientes con SCASEST que no pueden someterse a una estrategia invasiva precoz (ICPP) en < 24h.

114 ¿Qué tratamiento antiagregante sería el más adecuado si el paciente presenta una escala Grace de 125 puntos, CRUSADE 35 y la ICP (Intervencionismo Coronario Percutáneo) se realiza posterior a las 24h?

- A) AAS 300 mgr + Clopidogrel 300mgr.
- B) AAS 300 mgr + Prasugrel 60 mgr.
- C) AAS 300 mgr + Ticagrelor 180 mgr.
- D) Sólo AAS 300 mgr.

115 En relación al tratamiento anticoagulante periprocedimiento, indique la respuesta FALSA:

- A) Se recomienda seleccionar la anticoagulación según los riesgos isquémico y hemorrágico, además del perfil de eficacia y seguridad del fármaco.
 - B) Para pacientes que se someten a ICP, está recomendada la administración de Heparina No Fraccionada (HNF) durante la ICP con bolo intravenoso ajustado al peso de 70-100 UI/kg.
 - C) Se recomienda el uso de Fondaparinux en el SCASEST, independientemente de cuándo se realice la ICP.
 - D) La Enoxaparina debe considerarse como alternativa a la HNF si la ICP se realiza en menos de 24h.
-

CASO PRACTICO 4:

Traen a nuestro Servicio de Urgencias un paciente de 89 años, gran dependiente, institucionalizado en residencia de ancianos por deterioro cognitivo severo, con sondaje permanente por hiperplasia benigna de próstata que le ha provocado varios episodios de retención aguda de orina (RAO). Entre otros antecedentes de interés, diabético tipo 2, dislipémico, EPOC (con episodio de agudización leve hace menos de dos semanas, finalizando tratamiento con Amoxicilina-clavulánico hace 4 días). Derivan por deterioro progresivo del estado general en las últimas 24 horas, menos alerta, con tendencia al sueño, fiebre de 38.2°C y recorte de diuresis, sin clínica digestiva ni respiratoria aparentes. En la exploración a su llegada destaca mal estado general, tendente al sueño, signos de deshidratación de piel y mucosas, relleno capilar enlentecido. Neurológicamente no presenta focalidad grosera ni signos de meningismo; la auscultación cardiopulmonar y exploración abdominal y ORL son anodinas. Presión arterial (PA) 84/51 mmHg; Frecuencia cardiaca (FC) 110 latidos/minuto; Frecuencia respiratoria (FR): 26 respiraciones/minuto; Saturación Oxígeno (FiO₂ ambiente) 94%; T^a 38.4°C.

116 ¿Cuál de estas actitudes iniciales NO sería correcta en este caso?

- A) Canalización de dos vías periféricas e inicio de fluidoterapia.
- B) Reemplazo de la sonda.
- C) Solicitud de hemograma, bioquímica, coagulación, orina, gasometría venosa, radiografía de tórax y abdomen, hemocultivos y urocultivos y Ag y ARN de SARS-CoV2.
- D) Solicitud de TAC craneal.

117 Llegan resultados de las pruebas complementarias:

- Hemograma: Leucocitosis (12.500 leuc/microlitro) con neutrofilia. Hemoglobina 11.9 g/dl, Plaquetas 95.000 plaquetas/microlitro. Coagulación: Sin alteraciones.
- Bioquímica: Creatinina 3.1 mg/dl, urea 145 mg/dl, PCR 98 mg/l, procalcitonina 4.7 ng/dl.
- Gasometría venosa: pH 7,01, pCO₂ 31 mmHg, bicarbonato 11 mEq/l, EB -6.2, Lactato 7.8 mg/dl.
- Orina: Piuria, nitritos positivos. Proteinuria. Glucosuria. Hematuria de 20-25 hematíes/campo.
- Rx tórax: Sin hallazgos de interés.
- Rx abdomen: Imagen fusiforme de 8 x 3 mm de densidad calcio en región correspondiente a FII. Flebolitos pélvicos. Sin datos de obstrucción.
- Ag y ARN SARS-CoV2: Negativos.

De las siguientes decisiones, ¿cuál NO sería la correcta?

- A) Si retiramos la sonda del paciente, no volveremos a sondar para no aumentar la probabilidad de crear una infección urinaria de vías altas.
- B) Solicitaremos ecografía renal.
- C) Comenzaremos tratamiento antibiótico empírico precoz (a ser posible en los primeros momentos de atención al paciente).
- D) Monitorizaremos al paciente en Observación.

118 Respecto a la selección del tratamiento antibiótico, en este paciente debemos tener en cuenta todos los factores EXCEPTO uno de ellos:

- A) Tratamiento con antibióticos en los meses previos.
- B) Portador de sonda vesical permanente.
- C) Institucionalizado en residencia de ancianos (posible infección relacionada con atención sanitaria).
- D) Deterioro cognitivo.

119 En este caso, ¿qué microorganismo habría que considerar como posiblemente implicado en esta infección?

- A) Enterococcus.
- B) Pseudomona aeruginosa.
- C) Enterobacterias productoras de BLEE (β -lactamasas de espectro extendido).
- D) Todas las anteriores son ciertas.

120 ¿Qué antibiótico NO seleccionaría (ya sea en monoterapia o en asociación con otros) para este paciente?

- A) Ertapenem 1 gr intravenoso (iv) cada 24h.
- B) Fosfomicina disódica 6 gr iv cada 8h.
- C) Cefepime 1-2 gr iv cada 8-12h.
- D) Moxifloxacino 400 mg iv cada 24h.

CASO PRACTICO 5:

Varón de 72 años, independiente, con antecedentes de cardiopatía isquémica en tratamiento con antiagregantes. Llevado en ambulancia de UVI-Móvil a Urgencias del hospital por atropello hace 60 minutos. Ingresa en camilla, con collarín cervical y le han canalizado vía periférica y con extracción de muestras para analítica. El paciente está consciente y orientado, con apertura espontánea de ojos, habla sin dificultad y mueve los brazos con orden. Refiere dolor en región abdominopélvica, que se exacerba a la palpación en hipogastrio y que le limita la movilidad de ambos miembros inferiores. Sudoroso. Relleno capilar 2 segundos Las constantes son: Presión Arterial (PA) 80/40 mmHg, Frecuencia Cardíaca (FC) 120 latidos por minuto (lpm), Saturación de O2 97%, Frecuencia Respiratoria (FR) 20 respiraciones por minuto (rpm). Glucemia 85 mg/dl.

121 ¿Qué puntuación tiene según la escala de TRS (Trauma Score Revisado)?

- A) 12 puntos.
- B) 11 puntos.
- C) 10 puntos.
- D) 9 puntos.

122 ¿Qué tratamiento aplicaría en la evaluación primaria?

- A) Soluciones cristaloides isotónicas 1,5 litros en 20 minutos.
- B) Ácido Tranexámico 1g en 10 minutos.
- C) Cinturón pélvico.
- D) Todos los anteriores.

123 ¿Qué procedimientos complementarios solicitaría en la evaluación primaria?

- A) Radiología de tórax y pelvis.
- B) Ecografía FAST.
- C) TC abdominopélvico.
- D) Las opciones A) y B) son correctas.

124 A los 10 minutos, el paciente muestra sudoración profusa. Relleno capilar 3 segundos. Las constantes ahora son: PA 70/30 mmHg, FC 140 lpm, SO2 95%, FR 29 rpm. Glucemia 75 mg/dl. ¿Qué medida estaría indicada?

- A) Añadir soluciones glucosadas, para corregir la hipoglucemia.
- B) Añadir soluciones coloides, hasta llegada de resultados de analítica.
- C) Añadir fármacos vasopresores.
- D) Ninguna de las anteriores.

125 El paciente evoluciona favorablemente. Relleno capilar < 2 segundos. Las constantes son: PA 120/60 mmHg, FC 100 lpm, SO2 97%. Los hallazgos de las pruebas de imagen muestran fractura de sínfisis de pubis y de ramas isquio e iliopúbicas izquierdas, sin otros hallazgos. ¿Qué actitud estaría indicada?

- A) Tomografía Axial Computarizada abdominopélvica.
- B) Laparatomía.
- C) Angiografía.
- D) Punción lavado peritoneal.

CASO PRACTICO 6:

Varón de 21 años que es trasladado a Urgencias por ingesta hace 6 horas, de una cantidad aproximada de 30 comprimidos de un fármaco prescrito por depresión que no sabe precisar. Exploración física: A (vía aérea permeable), B (oxigenación y ventilación adecuada, saturación de O₂ 98%), C (auscultación cardio-respiratoria normal, FC 120 lpm, presión arterial 90/60 mmHg, buen relleno capilar), D (escala de Glasgow 15 puntos, pupilas midriáticas, glucemia 85 mg/dl), E (Temperatura 38°C).

126 ¿Qué actitud es la correcta?

- A) Vaciado del contenido gástrico mediante lavado-orogástrico.
- B) Carbón activado de forma sistemática e incluso en dosis repetidas.
- C) Canalización de vía venosa periférica e infusión de solución salina a un ritmo inicial de 2.000 ml/hora.
- D) Todas son actuaciones correctas.

127 ¿Qué antídoto estaría indicado en esta intoxicación?

- A) Fisostigmina.
- B) Flumazenilo.
- C) Atropina.
- D) Ninguno de las anteriores.

128 Durante su estancia en Urgencias, el paciente presenta una crisis convulsiva autolimitada. Se le realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones, que muestra un registro compatible con una taquicardia regular, con QRS 0.16 segundos, a una frecuencia de 180 sístoles por minuto. Mantiene pulso, aunque muy débil. ¿Qué fármaco es el de elección para tratar inicialmente esta arritmia en esta situación?

- A) Atenolol por vía intravenosa (i.v.)
- B) Amiodarona i.v.
- C) Bicarbonato i.v.
- D) Adenosina i.v.

129 ¿Qué medida terapéutica es la de elección, si persiste taquicardia ventricular tras la administración del fármaco anterior?

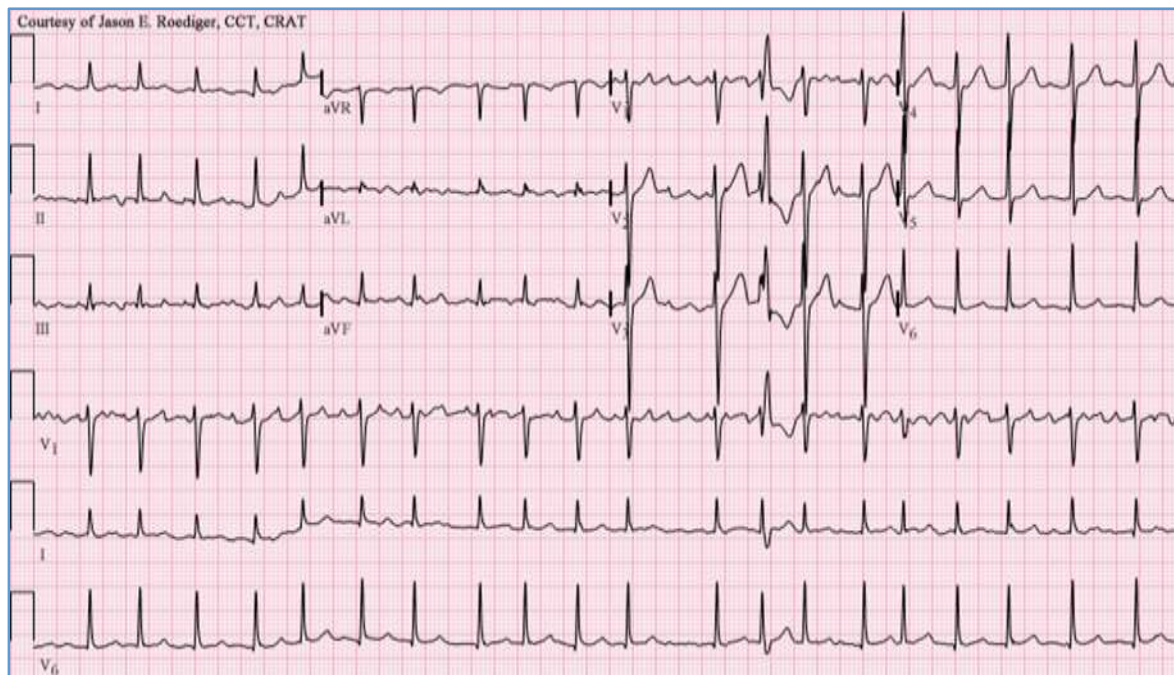
- A) Lidocaina i.v.
- B) Procainamida i.v.
- C) Verapamilo i.v.
- D) Flecainida i.v.

130 El paciente presenta nuevo episodio convulsivo. ¿Qué fármaco NO estaría indicado para el control de las crisis convulsivas?

- A) Midazolam.
- B) Difenilhidantoína.
- C) Lidocaína.
- D) Valproato sódico.

CASO PRÁCTICO 7:

Varón de 66 años que consulta por palpitaciones de 12 horas de evolución asociadas a disconfort centrotorácico. Hipertensión arterial en tratamiento con Losartán 50 mg. Diabetes mellitus en tratamiento dietético. No otros antecedentes de interés. Al ingreso en Urgencias, Presión arterial: 170/85 mmHg, Temperatura 36.5°C, eupneico. Auscultación cardiopulmonar: taquiarritmia sin soplos. No ruidos pulmonares patológicos. No edemas en miembros inferiores ni signos de trombosis venosa profunda. Se muestra el ECG de 12 derivaciones:



131 ¿Cuál es el diagnóstico electrocardiográfico?

- A) Taquicardia sinusal.
- B) Flúter auricular.
- C) Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.
- D) Síndrome de Wolff-Parkinson-White.

132 El manejo inicial del paciente, óptimo en la situación actual, es:

- A) Estrategia de control de frecuencia cardíaca y derivación a Cardiología para estudio.
- B) Administración de 6 mg de Adenosina i.v. para realizar diagnóstico.
- C) Control de frecuencia cardíaca mientras se realizan pruebas complementarias, y si persiste el trastorno ECG, valorar estrategia de restauración a ritmo sinusal.
- D) Administración de Amiodarona i.v. para tratamiento definitivo.

133 En las pruebas complementarias realizadas se objetiva una radiografía de tórax sin cardiomegalia ni signos de insuficiencia cardiaca congestiva, y resultados de hemograma, coagulación y bioquímica con función renal e iones en valores normales. Tras la decisión estratégica anterior, el paciente presenta mejora de los síntomas pero persiste el trastorno arritmico. ¿Cuál sería su decisión terapéutica en este momento?

- A) No se puede intentar la cardioversión sin un ecocardiografía.
- B) Se administra nueva dosis de Amiodarona para realizar tratamiento definitivo.
- C) Se administra nueva dosis de betabloqueante o calcioantagonista para control de frecuencia.
- D) Con los datos disponibles puede descartarse con seguridad una cardiopatía estructural significativa.

134 Tras conocer la normalidad de las pruebas complementarias, ¿qué fármaco estaría indicado en este paciente?

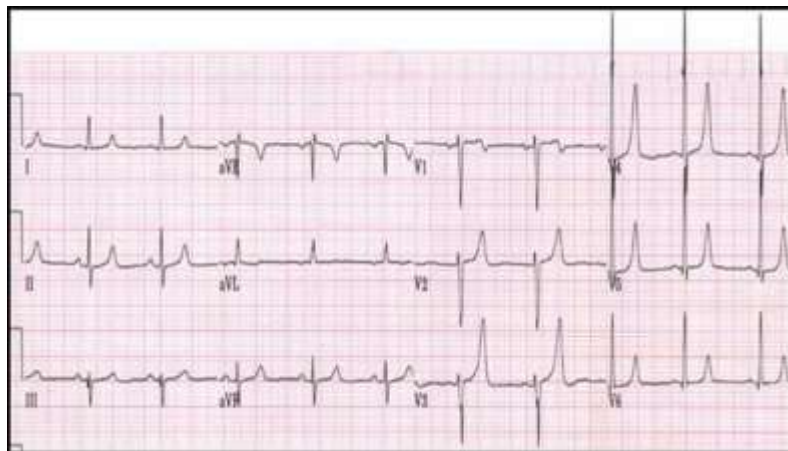
- A) Atenolol.
- B) Diltiazem.
- C) Amiodarona.
- D) Flecainida.

135 En este paciente, en relación al tratamiento al alta a domicilio, ¿cuál es la respuesta correcta?

- A) Está indicada la anticoagulación, ya que el paciente tiene CHADS2-VASc de 3 puntos y HAS-BLED de 2 puntos.
- B) No está indicada la anticoagulación, ya que el paciente tiene CHADS2-VASc de 1 punto y HAS-BLED de 6 puntos.
- C) Está indicada la anticoagulación, ya que el paciente tiene CHADS2-VACs de 4 puntos y HAS-BLED de 5.
- D) No está indicada la anticoagulación, ya que el paciente tiene CHADS2-VACs de 0 puntos.

CASO PRÁCTICO 8:

Hombre de 85 años que acude a Urgencias por presentar astenia, malestar general y diarrea. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica (Filtrado Glomerular 32 ml/min) e Insuficiencia Cardiaca (Fracción de Eyección de Ventrículo Izquierdo 30%). En tratamiento con Digoxina, Nebivolol, Furosemida, Alopurinol, Espironolactona, Enalapril, Atorvastatina y Sitagliptina. En la exploración destacan signos de deshidratación de mucosas. Presión arterial 90/44 mmHg; Frecuencia Cardiaca 120 latidos por minuto. Gasometría venosa: pH 7.31, bicarbonato 16 mmol/l. En electrocardiograma al ingreso se objetiva el trazado de 12 derivaciones que se muestra a continuación.



136 ¿Qué prueba solicitaría para confirmar el diagnóstico de sospecha?

- A) Tomografía Axial Computarizada (TAC) de tórax.
- B) Coronariografía urgente.
- C) Ecocardiografía transtorácico.
- D) Analítica de sangre con ionograma.

137 De los siguientes, ¿cuál considera que puede ser el diagnóstico de sospecha?

- A) Pericarditis aguda.
- B) Trastorno hidroelectrolítico.
- C) Síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
- D) Síndrome coronario agudo con elevación del ST.

138 ¿Cuál sería la primera medida a instaurar en este paciente?

- A) Administrar doble antiagregación.
- B) Administrar Gluconato Cálcico al 10% intravenoso (iv).
- C) Corregir la acidosis metabólica con Bicarbonato iv.
- D) Retirada de fármacos y añadir resinas de intercambio iónico.

139 Mientras se prepara el tratamiento indicado, el paciente presenta situación letárgica y el ECG se modifica (véalo al margen). Teniendo en cuenta la situación clínica y el trazado ECG, ¿cuál de las siguientes actuaciones sería la primera a realizar?



- A) Sedación y cardioversión eléctrica.
- B) Amiodarona intravenosa.
- C) Coronariografía urgente.
- D) Pericardiocentesis.

140 Una vez resuelta la situación aguda ¿cuál es el tratamiento definitivo de este paciente?

- A) Coronariografía programada.
 - B) By-pass aortocoronario.
 - C) Colchicina durante 6 semanas.
 - D) Modificación de tratamiento crónico del paciente.
-

CASO PRÁCTICO 9:

Consulta en nuestro Servicio de Urgencias una mujer de 34 años, sin antecedentes de interés salvo tabaquismo de 10 cigarrillos/día y toma anticonceptivos hormonales orales desde hace más de un año. Nos refiere aumento del perímetro de región gemelar de miembro inferior derecho (MID) de 48 horas de evolución, con cierto dolor (no muy intenso), sin fiebre, sin antecedente traumático. A la exploración, encontramos una región gemelar derecha tumefacta, empastada, algo dolorosa, con cianosis ortostática. Dudoso aumento también de perímetro crural respecto al contralateral. Auscultación cardiopulmonar normal. Presión arterial (PA) 107/56 mmHg. Frecuencia cardíaca (FC) 80 lpm, Frecuencia respiratoria (FR) 20 rpm, SatO₂ 96%, T^a 36.9°C.

141 En este caso, ¿cuál de estas actitudes, en nuestra primera valoración, es INCORRECTA?

- A) Realización de analítica con hemograma, coagulación con dímero D y bioquímica.
- B) Administrar precozmente una primera dosis de Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM).
- C) Realización de electrocardiograma (ECG).
- D) Estratificar el riesgo de presentar evento tromboembólico, con cualquiera de las escalas/algoritmos validados a tal efecto.

142 Establecido el diagnóstico de sospecha, señale en este caso cuál de las siguientes proposiciones o enunciados es FALSO:

- A) Si presenta baja probabilidad en escala de Wells y dímero D elevado: Realizar ecografía-doppler de sistema venoso de MID.
- B) Si la probabilidad pretest es alta, el dímero D elevado y la eco no demuestra trombosis venosa profunda (TVP), sería recomendable repetir eco-doppler en 7-10 días.
- C) Si se descarta TVP pero se confirma trombosis venosa superficial (TVS) con un trombo mayor de 5 cm a más de 3 cm del cayado safeno-femoral, indicaremos Fondaparinux como tratamiento de elección.
- D) Una TVP que se presenta como flegmasía alba dolens, generalmente no requiere ingreso, salvo que tenga alto riesgo de complicaciones con el tratamiento anticoagulante.

143 A nuestra paciente se le realiza la ecografía-doppler y se confirma que sufre una TVP de la vena femoral derecha (inmediatamente caudal a la desembocadura de cayado de safena mayor) hasta la vena poplítea. Se indica ingreso en Planta de Hospitalización y, a la espera de cama, nos avisan porque la paciente ha presentado un síncope en sala de espera. Se traslada a Box de Emergencias y, a pesar de recuperación espontánea, observamos franco deterioro del estado general con diaforesis y taquipnea, refiriéndonos la paciente intenso dolor torácico de características pleuríticas, disnea y palpitaciones. En la nueva toma de constantes: PA 94/43 mmHg; FC 115 lpm; Sat O2 91% (se administra O2 en mascarilla reservorio, sin mejora de la saturación); FR 36 rpm; Tª 37,1°C. Ante este cambio clínico, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Solicitamos nuevo ECG y bioquímica con troponina y proBNP.
- B) Solicitaremos angioTAC de arterias pulmonares, o una gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión si la paciente fuese alérgica a contrastes yodados (y existiera disponibilidad de dicha prueba).
- C) Si realizamos una ecografía clínica a pie de cama, un aumento de tamaño del ventrículo derecho con disfunción de éste, suponen sobrecarga derecha y peor pronóstico para la paciente.
- D) Comenzaremos con tratamiento anticoagulante inmediatamente a la confirmación diagnóstica de TEP, habiendo descartado antes otras causas (neumonía, IAM...).

144 Antes del síncope y la inestabilización clínica y hemodinámica de la paciente, se le había realizado una radiografía de tórax PA y lateral, que revisamos. Señale cuál es la afirmación FALSA al respecto de los hallazgos radiológicos que podemos encontrar en este proceso:

- A) Joroba de Hampton (como signo de infarto pulmonar).
- B) Infiltrado intersticial periférico de predominio apical.
- C) Signo de Westermarck (área/s de hiperclaridad marcada por defecto de perfusión).
- D) Derrame pleural y atelectasias basales.

145 Finalmente a nuestra paciente se le puede realizar el angioTAC y se confirma TEP agudo bilateral masivo con signos de sobrecarga derecha y varias localizaciones de infartos pulmonares periféricos. Trasladamos a nuestra Observación y, tras más de 30 minutos, mantiene hipotensión (PA 82/41 mmHg) y taquicardia (sinusal) a 120 lpm, taquipnea (44 rpm) y Sat O2 91% a pesar de reservorio. Señale la respuesta correcta:

- A) Ante el intenso trabajo respiratorio y baja Sat O2, iniciamos VMNI (BiPAP) como medida para resolver la probable acidosis respiratoria.
- B) En la escala pronóstica PESI simplificada obtenemos 3 puntos.
- C) Podemos administrar Heparina sódica (no fraccionada) hasta que se inicie tratamiento de reperfusión (preferentemente con rtPA).
- D) En el TEP de riesgo no alto, se dispone de varias alternativas terapéuticas entre las que tenemos Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM) y anticoagulantes de acción directa, no estando indicado el Fondaparinux.

CASO PRACTICO 10:

Paciente, varón de 35 años, sin antecedentes médicos de interés. Hace 3 días diagnosticado de neumonía adquirida en la comunidad por su médico de cabecera. Se maneja con antibióticos orales. Esta noche ha estado peor, con mayor disnea, y su hermana -cuando por la mañana le va a dar el desayuno- no puede despertarlo. Avisan a su médico de atención primaria. Cuando el médico llega al domicilio, su hermana lo ha intentado incorporar en la cama, pero está con la cabeza inclinada, gorgoteo respiratorio, taquipneico a 40 respiraciones por minuto (rpm) y Frecuencia Cardíaca (FC) de 130 sístoles por minuto (spm). Saturación de oxígeno (SatO2) 89%.

146 ¿Cuál es el criterio de activación del Sistema de Emergencias?

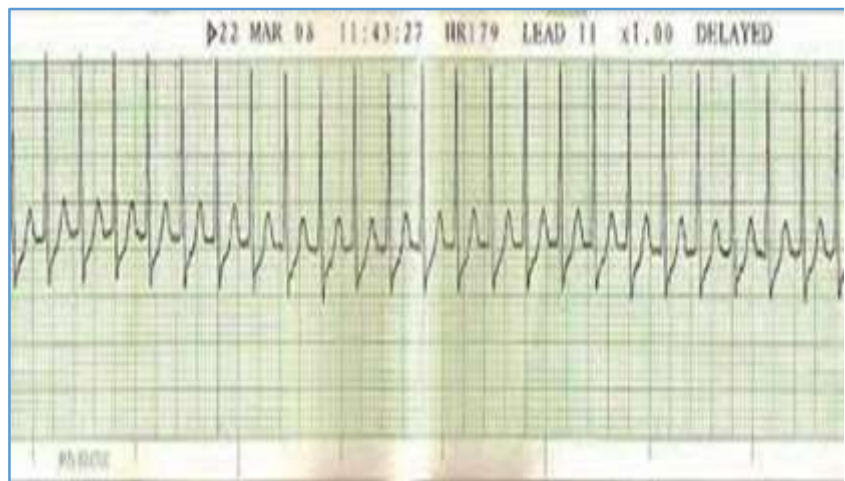
- A) SatO2 de 89%.
- B) Vía aérea permeable.
- C) Taquipnea de 40 rpm.
- D) FC de 130 spm.

147 El paciente deja de respirar. ¿Qué tenemos que hacer?

- A) Aplicar oxígeno a alto flujo.
- B) Intubación endotraqueal inmediatamente, aunque no tengamos experiencia.
- C) Monitorizar al paciente, acceso venoso, control de presión arterial y valoración inicial del paciente (ABCDE).
- D) Comprobar pulso central (carotideo) y, si está ausente, comenzar con compresiones torácicas.

148 El paciente está inconsciente, no respira y no tiene pulso. ¿Qué tratamiento iniciaríamos si el monitor muestra el siguiente trazado?

- A) Adenosina 12 mg vía intravenosa (iv).
- B) Amiodarona 300 mg iv.
- C) Adrenalina 1 mg iv.
- D) Atropina 1 mg iv.



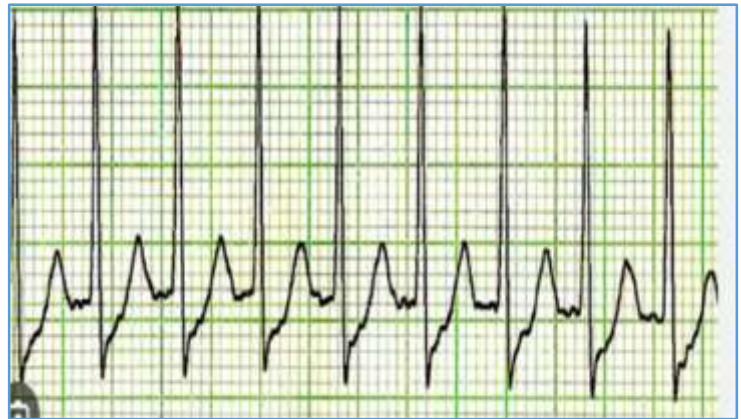
149 Señale la pauta correcta de actuación si, a pesar de la RCP (resucitación cardiopulmolar), tras 2 minutos de compresiones, el electrocardiograma cambia al siguiente ritmo:

- A) Verificar monitor, continuar 2 minutos de RCP y desfibrilar.
- B) Intubar al paciente.
- C) Verificar monitor, desfibrilar y hacer 2 minutos de RCP.
- D) Administrar 1 mg de adrenalina y 300 mg de amiodarona.



150 Señale la actuación correcta si, aplicado el tratamiento, aparece este ritmo en el monitor:

- A) Como aparece un ritmo sinusal paramos la RCP.
- B) Parece una taquicardia que va a 150 spm, por lo que pondremos Adenosina iv, ya que está inestable hemodinámicamente.
- C) Antes de parar la RCP comprobamos que haya pulso central.
- D) Seguimos RCP hasta que haya ritmo sinusal.



**APES_MÉDICO/A DE FAMILIA
EN UNIDADES DE URGENCIA
HOSPITALARIA 2023 / TURNO
LIBRE**

**CUESTIONARIO
RESERVA**

151 Uno de los siguientes efectos sobre el aparato respiratorio NO es un beneficio obtenido al aplicar alto flujo con cánulas nasales. Señálelo:

- A) Lavado del espacio muerto y disminución de la presión parcial de CO₂.
- B) Presión positiva durante la espiración.
- C) La fracción inspiratoria de oxígeno administrada a nivel alveolar será fijo y predecible aunque el paciente respire con la boca abierta.
- D) Aumenta el volumen corriente y disminuye la frecuencia respiratoria.

152 En el paciente politraumatizado en shock, ¿cuál de los siguientes parámetros es el mejor para guiar la resucitación e indica la resolución del shock?

- A) Normalización del lactato sérico.
- B) Normalización de la diuresis.
- C) Normalización de la tensión arterial.
- D) Normalización de la frecuencia cardíaca.

153 Dentro de las recomendaciones para la atención a los pacientes con síncope en el Servicio de Urgencias, ¿cuál de las siguientes respuestas es la verdadera?

- A) En el Servicio de Urgencias, el presíncope no debe recibir una atención similar a la del síncope, ya que tiene un pronóstico más leve.
- B) Las pruebas radiológicas y de laboratorio, como la radiografía torácica, la tomografía computarizada cerebral, la hematología habitual, la bioquímica sanguínea, la prueba del dímero D y los marcadores cardíacos, tienen un rendimiento diagnóstico alto y deben emplearse sistemáticamente.
- C) Las escalas de estratificación del riesgo no son superiores al buen juicio médico, y no deben emplearse solas para estratificar el riesgo en el Servicio de Urgencias.
- D) Se recomienda que los pacientes con características de bajo riesgo, que posiblemente sufran síncope reflejo o situacional, o síncope por hipotensión, sean ingresados para confirmar el diagnóstico.

INSTRUCCIONES PARA LAS PERSONAS OPOSITORAS:

Las personas opositoras están obligadas a colaborar en el correcto desarrollo del examen cumpliendo las siguientes instrucciones; en caso contrario nos veríamos obligados a pedirle que abandone el examen.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES QUE A CONTINUACIÓN LE DETALLAMOS SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.

SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS:

- ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con TELÉFONO MÓVIL (o cualquier otro dispositivo electrónico conectado a datos).
- En caso de que necesite algún dispositivo electrónico por tema médico o relacionado con medidas de seguridad en el ámbito de la violencia de género, informe de ello a su entrada en el aula, y le indicarán qué instrucciones específicas debe seguir.
- SI SE LE HUBIERA OLVIDADO DEJAR EL MÓVIL EN CASA O A UN ACOMPAÑANTE, TIENE QUE PONERLO EN CONOCIMIENTO Y ENTREGÁRSELO A LOS RESPONSABLES DEL AULA, QUE LO CUSTODIARÁN HASTA FINALIZAR SU PRUEBA:
- Para ello le entregarán un sobre con autopegado, en el que deberá escribir su DNI, nombre y apellidos, introducir el dispositivo apagado en el sobre, cerrarlo y dejarlo claramente visible en su mesa de examen para que, antes del inicio del reparto de los cuadernillos de examen, sea depositado por las personas de la organización en la mesa del responsable del aula.
- Finalizada la prueba, podrá recoger su móvil tras la presentación de su DNI.

SOBRE EL CORRECTO DESARROLLO DE LA PRUEBA:

- ENCIMA DE LA MESA DE EXAMEN SÓLO PUEDEN ESTAR su documento identificativo (DNI, pasaporte), el cuadernillo de examen y la hoja de respuesta que se le entreguen, el/ los bolígrafo/s y, en su caso, una botella de agua y caramelos. Los enseres personales, como bolsos, carteras, mochilas, etc., debe colocarlos en el suelo, a sus pies.
- ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PERSONAS OPOSITORAS Y ENTRE ÉSTAS Y EL EXTERIOR, ASÍ COMO EL USO Y TENENCIA DE DISPOSITIVOS MÓVILES.
- NO ESTÁ PERMITIDO LEVANTARSE DEL ASIENTO NI SALIR DEL AULA EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA HASTA EL MOMENTO EN QUE SE INICIE EL EJERCICIO. Después, podrá ir al baño, siempre acompañado por uno de los vigilantes del aula.

SOBRE EL CONTENIDO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN:

- Iniciada la prueba, si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, levante la mano y, cuando le atiendan, solicite su sustitución.
- Si entiende que existen preguntas confusas, incorrectamente formuladas o con respuestas erróneas, **LE RECORDAMOS QUE LA/S ALEGACIÓN/ES A LA/S PREGUNTA/S HA DE REALIZARSE A TRAVÉS DE LA V.E.C. EN LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN.**

NO ESTÁ PERMITIDO INTERRUPIR EL CORRECTO DESARROLLO DEL EXAMEN.

ANTE CUALQUIER CUESTIÓN O INCIDENCIA QUE TENGA, LEVANTE LA MANO Y ESPERE SENTADO/A Y EN SILENCIO A QUE LE ATIENDAN LAS PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL DESARROLLO DE LA PRUEBA.

